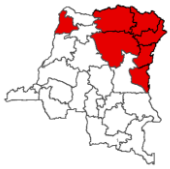
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°153 /MVE-BDBV/15/10/2026

Date du rapport : 15 octobre 2026 Date de publication : 16 octobre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Des progrès encourageants sont enregistrés dans la réduction de la mortalité, avec 18 décès communautaires contre 22 la veille et 14 le 08 octobre. Les décès intra-CTE ont également diminué à 14, contre 15 la veille et 19 le 08 octobre.
- Une baisse des nouveaux cas est observée au Nord-Kivu, avec 22 cas contre 28 la veille et 30 le 08 octobre. Toutefois, 71 nouveaux cas ont été notifiés au niveau national, contre 65 la veille et 58 le 08 octobre, répartis entre l'Ituri (41), le Nord-Kivu (22), la Tshopo (7) et le Haut-Uélé (1).
- Au laboratoire, 462 échantillons ont été analysés, contre 506 la veille et 390 le 08 octobre, avec un taux de positivité de 15,4 %, contre respectivement 12,8 % et 14,9 %, appelant au renforcement de la surveillance et du dépistage précoce.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
9348	4 510	48,2 %	916	2 507	79,2%

Provinces touchées et zones de santé touchées

7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et Sud Ubangi

65 Zones de santé touchées sur 167 (38,9%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Des progrès encourageants sont enregistrés dans la réduction de la mortalité liée à la MVE, avec 18 décès communautaires contre 22 la veille, soit une baisse de 18,2 %. Les décès intra-CTE ont également diminué à 14, contre 15 la veille et 19 le 08 octobre, portant le total des décès du jour à 32, contre 37 la veille et 33 le 08 octobre.

Une diminution des nouveaux cas est observée au Nord-Kivu, avec 22 cas contre 28 la veille et 30 le 08 octobre. Toutefois, 71 nouveaux cas confirmés ont été notifiés au niveau national, contre 65 la veille et 58 le 08 octobre, répartis entre l'Ituri (41), le Nord-Kivu (22), la Tshopo (7) et le Haut-Uélé (1).

Sur le plan de la prise en charge, 21 nouvelles guérisons ont été enregistrées, dont 11 en Ituri et 10 au Nord-Kivu, portant le cumul national à 2 507 patients guéris, contre 2 486 la veille et 2 320 le 08 octobre.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule 9 348 cas confirmés et 4 510 décès, soit une létalité de 48,2 %, en légère baisse par rapport aux 48,3 % enregistrés la veille et le 08 octobre. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 73,2 % des cas cumulés et 57,7 % des nouveaux cas.

Au total, 65 zones de santé sur 167 (38,9 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie, une situation inchangée par rapport à la veille et au 08 octobre.

Il sied de signaler que **12 ZS ont atteint au moins 42 jours sans nouveau cas confirmé et 3 ZS** se retrouvent entre **22 et 42 jours sans nouveau cas confirmé**. Cependant, **269 PPL** ont été touchés par la MVE BDB_17. La répartition des PPL sont répartis de la manière suivante : Bas-Uele (1), Haut-Uele (31), Ituri (180), Nord-Kivu (45) et Tshopo (12).

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES CAS ET DÉCÈS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET SITUATION DES ZONES DE SANTÉ, AU 15 OCTOBRE 2026

Province	Nouveaux cas confirmés (24 h)	Cas confirmés cumulés	Décès confirmés cumulés	Létalité	ZS historiquement touchées	ZS actuellement affectées*
Ituri	41	6 847	3 164	46,2 %	28/36 (77,8 %)	25/36
Nord-Kivu	22	2 013	1 146	56,9 %	17/34 (50,0 %)	15/34
Haut-Uélé	1	399	169	42,4 %	7/13 (53,8 %)	7/13
Tshopo	7	71	25	35,2 %	7/23 (30,4 %)	5/23
Sud-Kivu	0	3	1	33,3 %	1/34 (2,9 %)	0/34
Bas-Uélé	0	13	4	30,8 %	4/11 (36,4 %)	4/11
Sud-Ubangi	0	2	1	50,0 %	1/16 (6,3 %)	1/16
Total	**71**	**9 348**	**4 510**	**48,2 %**	**65/167 (38,9 %)**	**57 ZS dans 5 provinces**

COMMENTAIRES : La létalité nationale recule légèrement à 48,2 % (48,3 % le 08 octobre) et les nouveaux cas diminuent au Nord-Kivu (22 contre 30). La hausse des cas en Ituri (41 contre 20) et dans la Tshopo (7 contre 4) justifie le renforcement ciblé de la surveillance et des interventions communautaires dans ces provinces ci-haut citées.

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 15 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**6847**	**3164**	**46,2%**	**41**	**10**	**6**	**16**
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	9	6	66,7%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	216	48	22,2%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1869	623	33,3%	3	1	1	2
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	11	7	63,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	187	113	60,4%	2	0	1	1
Lita	307	155	50,5%				0
Logo	14	8	57,1%				0
Lolwa	36	9	25,0%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	65	25	38,5%	3	2	0	2
Mandima	298	149	50,0%	21	7	0	7
Mangala	375	162	43,2%	3	0	0	0
Mongbwalu	713	342	48,0%				0
Nia-Nia	329	190	57,8%			2	2
Nizi	822	297	36,1%			2	2

Nyankunde	134	39	29,1%				0
Rimba	19	5	26,3%				0
Rwampara	1151	398	34,6%	9	0	0	0
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	**2013**	**1146**	**56,9%**	**22**	**7**	**6**	**13**
Beni	498	336	67,5%	7	5	5	10
Biena	23	7	30,4%				0
Butembo	311	187	60,1%	4	0	0	0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	75	29	38,7%	1	0	0	0
Katwa	637	390	61,2%	4	1	0	1
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	42	21	50,0%	2	0	0	0
Lubero	32	14	43,8%	3	1	0	1
Mabalako	70	28	40,0%	1	0	0	0
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	15	5	33,3%				0
Masereka	39	13	33,3%			1	1
Musienene	151	71	47,0%				0
Mutwanga	24	5	20,8%				0
Oicha	47	21	44,7%				0
Vuhovi	40	14	35,0%				0
Haut-Uélé	**399**	**169**	**42,4%**	**1**	**0**	**2**	**2**
Boma Mangbetu	44	19	43,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	105	46	43,8%				0
Pawa	102	51	50,0%	1	0	1	1
Rungu	5	3	60,0%				0
Wamba	139	48	34,5%	0	0	1	1
Tshopo	**71**	**25**	**35,2%**	7	1	0	1
Bafwasende	17	2	11,8%	7	1	0	1
Kabondo	8	1	12,5%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	32	14	43,8%				0
Mangobo	10	7	70,0%				0
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0

Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	**9348**	**4510**	**48,2%**	**71**	**18**	**14**	**32**

Tableau 3. Situation des alertes notifiées 14 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	184	0	184	9	0	175	0	9	9
Bas Uélé	245	2	247	64	2	181	0	66	0
Ituri	1 450	73	1 523	170	73	1 280	0	227	137
Nord-Kivu	1 522	64	1 586	147	64	1 375	0	211	94
Sud Ubangi	98	0	98	1	0	97	0	1	0
Tshopo	139	2	141	13	2	126	0	15	0
Total Général	**3 638**	**141**	**3 779**	**404**	**141**	**3 234**	**0**	**529**	**240**

La surveillance épidémiologique demeure active, avec 3 779 alertes reçues, dont 545 validées comme cas suspects (14,4 %). Parmi celles-ci, 529 suspects ont été investigués (97,1 %) et 240 transférés vers les CT/CTE. L'Ituri et le Nord-Kivu concentrent 82,3 % des alertes, traduisant une forte sollicitation du dispositif de surveillance. Ces résultats témoignent des efforts de détection et d'investigation, mais nécessitent de renforcer la promptitude des investigations, notamment pour les 16 suspects restant à investiguer, ainsi que le référencement rapide des malades.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

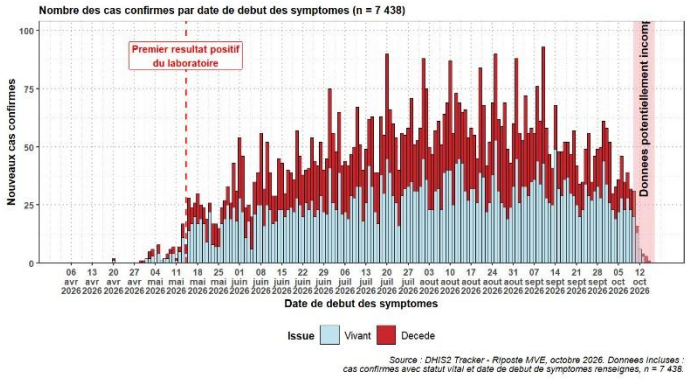
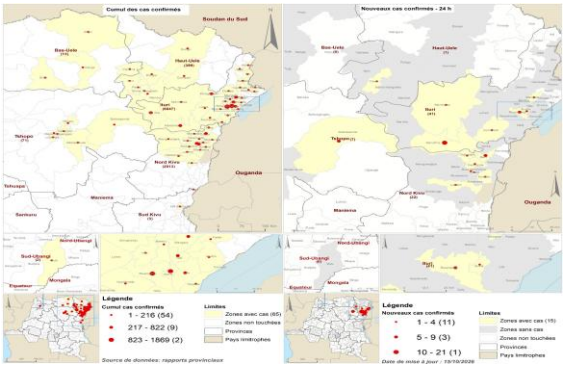


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Renforcement de la coordination stratégique et opérationnelle de la riposte à la 17e épidémie de maladie à virus Ebola (MVE), sous le leadership de l'Incident Manager (IM), en collaboration avec les autorités sanitaires provinciales et les partenaires techniques et financiers ;
- Appui technique et opérationnel aux activités de riposte dans les provinces affectées, à travers les différents piliers, notamment la surveillance épidémiologique, le laboratoire, la prise en charge, la PCI/EDS, la vaccination et la communication sur les risques et l'engagement communautaire (CREC) ;
- Renforcement du suivi des interventions dans les principaux foyers actifs, particulièrement en Ituri, au Nord-Kivu, dans la Tshopo et au Haut-Uélé, avec un accent sur la réduction des décès communautaires et l'interruption des chaînes de transmission ;
- Poursuite des missions de supervision, d'accompagnement technique et de concertation avec les autorités politico-administratives et sanitaires provinciaux, en vue d'améliorer la coordination des interventions sur le terrain.
- Suivi des indicateurs de performance des piliers, analyse des progrès réalisés et identification des insuffisances opérationnelles nécessitant des mesures correctrices rapides ;
- Renforcement de la concertation avec les partenaires techniques et financiers pour la mobilisation, l'allocation rationnelle et le suivi des ressources nécessaires à la riposte ;
- Consolidation des mécanismes de redevabilité, de gestion de l'information et de partage régulier des données entre les coordinations provinciales et la Coordination nationale.

1.2. Défi majeur

Persistance des chaînes de transmission communautaire dans certains foyers actifs, notamment à Mandima, Beni et Bafwasende, dans un contexte de contraintes sécuritaires, logistiques et financières, nécessitant le renforcement de la coordination inter piliers, de la mobilisation des ressources et du suivi des interventions pour consolider les acquis de la riposte.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Malgré l'amélioration du suivi des contacts (79,2 % contre 78,0 % la veille) et la forte proportion de cas suspects investigués (97,1 %), la couverture du suivi demeure inférieure à la cible de 95 %, avec 7 330 contacts non vus et 16 suspects non investigués, nécessitant le renforcement de la recherche active, des investigations et du suivi communautaire, particulièrement dans les foyers de transmission actifs.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Le 15 octobre, **14** alertes ont été notifiées aux PoE/PoC des cinq provinces suivies : 12 en Ituri, 1 au Nord-Kivu et 1 au Sud-Kivu. Elles comprennent 7 alertes vivantes validées comme cas suspects (6 en Ituri et 1 au Nord-Kivu), dont 3 (42,9 %) ont été transférées vers les CT/CTE, et 4 corps sans vie interceptés (3 en Ituri et 1 au Sud-Kivu), dont 2 (50,0 %) ont été swabés ou sécurisés ; toutes les alertes vivantes ont été investiguées.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 15 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Global
Complétude des rapports	98,4% (60/61)	90,5% (19/21)	55,6% (5/9)	100,0% (18/18)	90,0% (9/10)	93,3% (111/119)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	ND	100%	90%	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	146 665	76 319	6 945	18 265	16 881	265 075
% des voyageurs screenés	97,5%	98,0%	98,1%	98,3%	99,0%	97,8%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,3%	98,0%	98,1%	98,6%	99,0%	97,7%
% des voyageurs sensibilisés	99,6%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,2%
Nombre d'alertes notifiées	12	1	1	0	0	14
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	6	1	0	0	0	7
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	3	0	1	0	0	4
% des cas suspects transférés au CTE/CT	33,3%	100,0%	NA	NA	NA	42,9%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	66,7%	NA	0,0%	NA	NA	50,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	100,0%	NA	NA	NA	100,0%

2.2.2. Défis

Malgré l'amélioration du suivi des contacts (79,2 % contre 78,0 % la veille) et la forte proportion de cas suspects investigués (97,1 %), la couverture du suivi demeure inférieure à la cible de 95 %, avec 7 330 contacts non vus et 16 suspects non investigués, nécessitant le renforcement de la recherche active, des investigations et du suivi communautaire, particulièrement dans les foyers de transmission actifs.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 41 nouveaux résultats positifs** (31 vivants et 10 décès) sur 270 échantillons reçus et analysés **(positivité : 15,2%) ;**
- **Nord-Kivu : 22 nouveaux résultats positifs** (15 vivants et 7 décès) sur 128 échantillons reçus et analysés **(positivité : 17,8%) ;**
- **Haut-Uélé : 1 nouveaux résultats positifs (**1 vivant) **sur 21 échantillons reçus et analysés (positivité : 4,8%) ;**
- **Tshopo : 7 nouveau cas confirmé (6 vivants et 1 décès) sur 16 échantillons reçus et analysés (positivité : 43,8%) ;**
- **Bas Uélé :** 27 nouveaux échantillons reçus au laboratoire de Buta et Isiro analysés tous négatifs.

2.3.2. Défi majeur

Persistance d'une forte positivité des échantillons dans certains foyers actifs, particulièrement dans la Tshopo (43,8 %) et au Nord-Kivu (17,8 %), nécessitant le renforcement des capacités diagnostiques, de l'acheminement rapide des prélèvements et de la promptitude du rendu des résultats pour assurer une détection précoce et interrompre les chaînes de transmission.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri :** 16 rings ont été ouverts sur 26 (61,5 %), 28 ménages décontaminés sur 35 (80,0 %) et 4 FOSA décontaminées sur 6 (66,7 %). Sur 102 alertes EDS (dont 14 reports de la veille), 64 EDS ont été réalisés (62,7 %) et 69 corps swabés sur 90 (76,7 %) ;
- **Haut-Uélé :** 6 ESS sur 6 prévus (100 %) ont été décontaminés (1 à Isiro, 1 à Pawa et 4 à Wamba), 69 prestataires ont été briefés (28 à Isiro, 28 à Pawa, 9 à Wamba et 4 à Boma Mangbetu) et 9 ESS ont été évalués, avec des scores allant de 13,0 % au CS Bevesieni à 80,0 % au CS Nebobongo ; aucun ring n'a été ouvert ni aucun ménage décontaminé. Les 3 alertes EDS de Wamba ont toutes donné lieu à un EDS complet avec swab (3/3) ;
- **Nord-Kivu :** 17 rings ont été ouverts sur 22 (77,3 %) et 10 ménages décontaminés sur 23 (43,5 %) ; 156 ESS ont été suivis, 325 prestataires briefés et 14 ESS évalués (score PCI moyen de 49,4 %), 15 PPL sur 26 étant classés à haut risque d'exposition, sans PPL infecté parmi les 28 derniers cas confirmés. Sur 57 alertes EDS et 50 reports de la veille, 62 EDS ont été réalisés (57,9 %) et 57 corps swabés ; 12 kits PCI-WASH ont été remis à deux écoles de Butembo lors de la Journée mondiale du lavage des mains et 10 000 litres d'eau ont été fournis au CTE de Katwa avec l'appui de la CAUB et de l'UNICEF ;
- Bas-Uélé : les prestataires de 9 ESS sur 9 ont été suivis dans les ZS de Buta, Viadana et Ganga, et 46 prestataires et 12 hygiénistes ont été briefés sur le port des EPI, la gestion des déchets et le triage (100 %) ; les DLM sont fonctionnels à l'HGR de Buta (12/12) mais pas au CH Rubi Lisanga (1/5), et les scores PCI atteignent 62 % au CSR Limba et 18 % au CS Mazulu (évaluation initiale). Deux EDS complets, avec 2 swabs, ont été réalisés à Ganga (AS Agri Uélé).

2.4.2. Défis

Insuffisance de la couverture des interventions PCI/EDS, particulièrement des enterrements dignes et sécurisés en Ituri (62,7 %) et au Nord-Kivu (57,9 %), associée à la faible décontamination des ménages, à l'ouverture incomplète des rings et aux insuffisances des dispositifs PCI dans certaines structures sanitaires, nécessitant le renforcement des capacités opérationnelles, des équipements et de la supervision pour limiter les risques de transmission communautaire et nosocomiale.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 60 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 82 sorties, dont 11 guérisons, confirmés) e, 384 patients sont hospitalisés, soit un taux d'occupation de 37,0 % (47,0 % pour les suspects et 27,0 % pour les confirmés), dont 44 malades critiques ; 32 patients ont été évacués par ambulance et 369 patients sur 377 (97,9 %) ont reçu un repas chaud ;
- **Au Nord-Kivu**, 97 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 86 sorties, dont 10 guérisons (Beni 5, Katwa 3 et Kalunguta 2). Ainsi, 464 patients (161 confirmés et 303 suspects, dont 67 enfants de moins de 5 ans) sont hospitalisés : 333 dans les CTE/CT pour 392 lits, soit un taux d'occupation de 84,9 %, et 131 dans des ESS non dédiés ; 5 malades **;**
- **Au Haut-Uélé**, 5 nouvelles admissions de suspects (Wamba 3 et Pawa 2) ont été enregistrées contre 8 sorties : 6 non-cas à Pawa et 2 décès de confirmés, sans guérison. Ainsi, 44 patients (16 confirmés et 28 suspects, dont 7 enfants de moins de 5 ans) sont hospitalisés pour 169 lits montés, soit un taux d'occupation de 26,0 %, dont 4 malades en état sévère ou critique ; 46 patients, 55 accompagnants et 70 PPL ont reçu des repas chauds ont été transportés par ambulance ;
- **À la Tshopo,** 8 nouvelles admissions (7 confirmés du CT de Bafwasende et 1 suspect), ainsi que la réadmission d'un guéri PPL, ont été enregistrées contre 1 sortie (non-cas), sans décès au CTE. Ainsi, 21 patients (13 confirmés, dont 9 à Bafwasende, et 8 suspects) sont hospitalisés pour 36 lits, soit un taux d'occupation de 58,3 % (92,9 % pour les lits des confirmés), sans malade en état sévère ; 3 confirmés restent perdus de vue (2 à Bafwasende et le motard de l'AS Marie Antoinette). Depuis le début, 41 cas confirmés ont reçu le traitement expérimental et 452 personnes la prophylaxie post-exposition **;**

- **Au Bas-Uélé**, aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré ; 3 patients restent en isolement, sans guérison ni décès notifié.

2.5.2. Défis

Insuffisance des capacités d'accueil et de prise en charge dans certains foyers actifs, particulièrement au Nord-Kivu (84,9 % d'occupation des CTE/CT et 131 patients hospitalisés hors structures dédiées) et dans la Tshopo (92,9 % d'occupation des lits réservés aux cas confirmés), associée à la présence de malades critiques, aux difficultés de référencement et aux cas confirmés perdus de vue, nécessitant le renforcement des capacités d'hospitalisation, des ambulances et de la qualité des soins pour réduire la mortalité et les risques de transmission.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, la vaccination des PPL par le vaccin Ervebo s'est poursuivie : 87 personnes supplémentaires ont été vaccinées, portant le cumul à 1 120 vaccinés (460 femmes et 660 hommes, dont 13 femmes enceintes et 26 allaitantes ; 2 MAPI), et la recherche sur l'efficacité du vaccin Ervebo contre la souche BDBV s'est poursuivie ;
- **Au Haut-Uélé**, 503 PPL ont été vaccinées sur 1 060 préenregistrées (47,5 %), dont 470 à Isiro et 33 à Pawa.

2.6.2. Défis majeurs

Couverture vaccinale encore insuffisante des personnes de première ligne (PPL), particulièrement au Haut-Uélé (47,5 %), nécessitant l'intensification de la mobilisation et de la vaccination des PPL, ainsi que la poursuite des études sur l'efficacité et la protection conférée par le vaccin Ervebo contre la souche Bundibugyo (BDBV).

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, l'évaluation de base du CH Carl Becker a relevé un triage exigu (un seul lit), l'absence d'EPI, de poubelles à pédale et de gel hydroalcoolique, des urgences fonctionnelles mais sans groupe électrogène de secours, 40 % des prestataires de la maternité non formés en SONUB et CPNr, l'absence de néonatologie et la non-intégration de la vaccination et de la prise en charge de la TB et du VIH ; 16 cas confirmés y ont été enregistrés, dont 1 prestataire, et 5 prestataires sont en quarantaine. Sur le plan nutritionnel, 188 confirmés, 195 suspects, 585 prestataires et 200 accompagnants ont reçu des repas chauds, 50 ménages de patients ont bénéficié de vivres et les 16 nourrissons séparés sont sous substitut de lait maternel (16/16) ;
- **À la Tshopo**, le CSR Alwaleed et le CS militaire Ketele ont été évalués : à Ketele, 15 agents sur 20 (75,0 %) sont vaccinés contre la MVE et 28 PVVIH sont suivis, mais les tests de dépistage du VIH sont en rupture ; à Alwaleed, la zone de triage et l'incinérateur sont fonctionnels et 55 enfants sur 55 ont été vaccinés lors d'une séance de CPS. Le plan de redressement du CS Massina est en cours d'élaboration et le suivi des guéris présentant des complications se poursuit à l'HGR de Makiso-Kisangani ;
- **En Ituri**, 74 enfants ont bénéficié d'une prise en charge nutritionnelle par LNPE/SLM : 7 sur 7 au CTE, 6 sur 6 à la crèche et 61 sur 61 dans la communauté.

2.7.2. Défis majeurs

Persistance des insuffisances en matière de prévention et contrôle des infections, d'équipements, de formation du personnel et de disponibilité des intrants essentiels dans certaines structures sanitaires, particulièrement au Nord-Kivu et dans la Tshopo, compromettant la sécurité des soins et la continuité des services essentiels, notamment la santé maternelle et néonatale, la vaccination, la prise en charge du VIH/TB et le suivi nutritionnel, nécessitant un renforcement urgent des capacités des structures de santé.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 21 237 visites à domicile ont touché 81 678 personnes ; 481 causeries éducatives ont réuni 15 287 personnes, 166 sensibilisations de masse 6 945 personnes, 23 débats communautaires 480 personnes et 7 plaidoyers 20 autorités religieuses et leaders, à Rwampara et à Komanda. Au total, 309 alertes communautaires, dont 139 décès, ont été notifiées ; 38 feedbacks sur 48 (79,2 %) et 6 incidents sur 6 (100 %) ont été résolus dans les 48 heures, et la CREC a facilité le pré-listage de 184 contacts autour de 4 cas confirmés, la décontamination de 40 ménages sur 40 (100 %), de 3 structures et de 3 ESS, 46 EDS sur 62 (74,2 %), l'annonce de 20 résultats positifs sur 20 et le transfert de 17 cas suspects sur 19 (89,5 %) vers les CTE. À Rwampara ;
- **Au Bas-Uélé**, 453 visites à domicile ont touché 1 068 personnes dans la ZS de Ganga, 3 sensibilisations de masse 603 personnes (Ganga, Aketi et Titule) et 3 causeries éducatives 72 personnes (Ganga et Viadana) ; un dialogue communautaire a réuni 51 personnes (21 femmes et 30 hommes) dans l'AS Sopi (Ganga) avec le chef de groupement Bamboule, autour du dernier cas confirmé, et 23 voyageurs ont été sensibilisés au point de contrôle de Dakwa Centre ;
- **Au Nord-Kivu**, 11 120 visites à domicile ont touché 39 389 personnes, 129 causeries éducatives 3 023 personnes, 16 communications de masse 3 265 personnes et 3 briefings 87 personnes ; 263 alertes communautaires ont été notifiées sur 650 attendues (40,5 %), 11 feedbacks sur 15 (73,3 %) ont été résolus dans les 48 heures et 1 736 personnes sur 4 750 (36,5 %) ont été engagées dans les actions communautaires. La sortie de 2 guéris au CTE de Katwa et de 3 guéris au CTE de Beni a été accompagnée de témoignages et d'une sensibilisation dans les AS de Malepe et de Ngongolio, des équipes ECUMR issues des groupes de pression et des leaders ont été constituées pour les foyers de résistance d'Eringeti (Oicha) et de Wayene (Katwa), les U-Reporters ont ciblé les populations autochtones des camps de déplacés d'Oicha et 28 chefs d'établissement et enseignants ont été briefés à Kalunguta ;
- **À la Tshopo**, une caravane motorisée a sillonné les artères de Kisangani pour sensibiliser la population aux gestes barrières et à la remontée des alertes, les visites à domicile se sont poursuivies dans les ZS de Mangobo, Tshopo, Kabondo et Makiso-Kisangani et un plaidoyer a été mené auprès de la direction de la BRALIMA ; environ 101 223 personnes ont été sensibilisées et 42 prestataires briefés à Lubunga, tandis que les 78 alertes communautaires et les 2 feedbacks notifiés ont tous été traités.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Ituri,** 20 derniers sur 31 (64,5 %), 64 confirmés en cours de suivi sur 122 (52,5 %), 20 nouveaux suspects sur 60 (33,3 %) et 114 suspects en cours de suivi sur 176 (64,8 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 146 accompagnants et 56 PPL, suivi 17 guéris sur 23 (73,9 %) en communauté et 15 enfants sur 15 en crèche, accompagné 7 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 11, réinséré 5 guéris sur 11 et annoncé 34 résultats, dont 20 positifs ; 40 enfants sont suivis ;
- **Au Nord-Kivu**, 25 derniers cas confirmés sur 28 (89,3 %), 212 confirmés en cours de suivi, 318 nouveaux suspects et 215 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans 5 ZS sur 7 ayant notifié (71,4 %) ; les équipes ont accompagné 88 ménages et 32 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 50 (64,0 %), soutenu 67 PPL, suivi 5 enfants sur 5 en crèche, réinséré 12 guéris, suivi 7 guéris sur 10 (70,0 %) en communauté et annoncé 137 résultats, dont 28 positifs ; 342 personnes (123 hommes, 145 femmes et 74 enfants) ont bénéficié de la psychoéducation avec l'appui de l'UNICEF ;
- **Au Haut-Uélé**, seules Isiro et Boma Mangbetu ont rapporté : 5 confirmés en cours de suivi, 1 nouveau suspect et 4 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, 16 accompagnants et 27 PPL ont été soutenus et 2 résultats, négatifs, ont été annoncés à Isiro, où 2 non-cas, dont 1 PPL, sont sortis du CTE ;
- **À la Tshopo**, 4 confirmés en cours de suivi sur 4 (100 %), 1 nouveau suspect sur 1 et 5 suspects en cours de suivi sur 5 ont bénéficié d'interventions SMSPS, mais aucun des 7

derniers cas confirmés de Bafwasende n'a encore été pris en charge (0/7) ; 386 personnes, dont 251 élèves du lycée de la Tshopo, ont bénéficié de la psychoéducation, 20 PPL ont été soutenus, 3 résultats, tous négatifs, ont été annoncés et 3 résistances sur 4 ont été brisées. La formation des leaders communautaires en santé mentale communautaire a été lancée.

2.9.2. Défis

Persistance des résistances communautaires dans certains foyers actifs, particulièrement au Nord-Kivu, associée à une faible remontée des alertes communautaires (40,5 % de l'objectif) et à une participation insuffisante des populations (36,5 %), nécessitant le renforcement de l'engagement des leaders locaux, de la mobilisation communautaire et de la gestion rapide des rumeurs et feedbacks pour améliorer l'adhésion aux interventions et interrompre les chaînes de transmission.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions.

Assurer la mobilité de toutes les équipes de terrain dans les provinces touchées ; au Nord-Kivu, les travaux de construction des cabanes au PoC PK5 et de la cabane et de la passerelle des voyageurs à l'aéroport de Beni se poursuivent avec l'appui de l'OIM ; au Haut-Uélé, les matériels ont été colisés pour l'activation de deux PoC (PK18 et Bangwene) dans la ZS de Wamba ; au Bas-Uélé, la construction du CTE de l'HGR de Buta (cloisonnement des chambres et toilettes) et la réhabilitation de la salle de réunion et des bureaux de la DPS avec l'appui de l'OMS se poursuivent, les équipes de surveillance ont été déployées à Ganga et à Viadana et la ZS de Buta, l'HGR et le laboratoire ont été approvisionnés ; à la Tshopo, le laboratoire a reçu un kit de panneaux solaires et un split de JHPIEGO.

2.10.2. Défis majeurs

Insuffisance des moyens logistiques et de mobilité des équipes de terrain, associée aux besoins persistants en infrastructures, équipements et approvisionnement des structures de riposte, particulièrement dans les zones difficiles d'accès, nécessitant l'accélération des travaux d'aménagement des PoC et des CTE, ainsi que le renforcement des capacités de transport et de la chaîne d'approvisionnement pour garantir la continuité et la promptitude des interventions.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions

Au Nord-Kivu, l'équipe EDS a bénéficié d'une couverture sécuritaire pour l'enterrement d'un cas confirmé au cimetière public de Bundji, et l'équipe PCI pour la décontamination de 2 ménages dans l'AS de Mangote ; la menace persiste contre les prestataires des PoC de l'axe Butembo et le PoC de Butuhe reste fermé depuis l'incident du 26/09/2026. À la Tshopo, des résistances communautaires et des agressions physiques ou menaces contre les équipes d'intervention rapide ont été signalées à Bafwasende, où le corps d'une patiente a été arraché de force à l'équipe EDS de la Croix-Rouge le 14/10/2026 ; en Ituri, le PoC d'Avakubi demeure non fonctionnel en raison de l'insécurité.

2.11.2. Défis majeurs

Persistance de l'insécurité, des menaces et des résistances communautaires contre les équipes de riposte, particulièrement au Nord-Kivu, en Ituri et dans la Tshopo, entraînant la fermeture de certains PoC et des perturbations des interventions PCI/EDS, nécessitant le renforcement de la sécurisation des équipes, de l'engagement communautaire et de la collaboration avec les autorités locales pour garantir la continuité des opérations.

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri,** 11 prestataires du CTE de Rwankole (6 femmes et 5 hommes) ont été briefés sur la PSEA/HS et ont signé le code de bonne conduite, 15 RECO et leaders communautaires (9 femmes et 6 hommes) ont été briefés à Mongbwalu, et 608 personnes ont été sensibilisées dans la communauté, dont 594 élèves et enseignants des écoles Anviiko et Amen à Aru et 14 conducteurs de triporteurs à Bunia ; l'affichage des messages et la distribution des dépliants

se sont poursuivis dans les ZS de Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki. Au Haut-Uélé, dans la ZS d'Isiro, 24 garde-malades et PPL du CH Telalingbi (7 hommes et 17 femmes), 6 autres PPL et un garde-malade, ainsi que 24 enseignants du collège la Victoire (20 hommes et 4 femmes) ont été sensibilisés sur la PSEA et le circuit de signalement aux numéros verts 495555 et 151 ; les PPL et 17 enseignants ont signé le code de bonne conduite

Au Nord-Kivu, 20 nouveaux prestataires ont été sensibilisés sur la PSEA et le numéro vert avec l'appui d'IMC, ainsi que 23 ECUMR (22 hommes et 1 femme) à Beni avec l'OMS et 92 jeunes (67 filles et 25 garçons) avec le CICR dans la ZS de Beni ; dans la ZS de Butembo, 40 personnes (32 femmes et 8 hommes) ont été sensibilisées sur la PSEA et les numéros verts 495555 et 151 avec l'appui de l'OMS, et 43 dépliants ont été distribués.

2.12.2. Défis

Couverture encore insuffisante des activités de sensibilisation et de formation à la PSEA dans certaines zones de riposte, associée à la nécessité de renforcer l'appropriation du code de bonne conduite, la connaissance des mécanismes confidentiels de signalement et la protection des populations vulnérables, afin de prévenir les risques d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuels et de garantir une riposte sûre et redevable.

2.13. Gestion des bases des données

2.13.1. Principales actions

- Poursuite de la collecte, de la centralisation, de la compilation et de l'analyse quotidienne des données épidémiologiques et opérationnelles transmises par les provinces affectées ;
- Renforcement du contrôle de qualité des données, notamment la vérification de leur complétude, de leur cohérence et de leur concordance entre les bases provinciales et la base nationale ;
- Poursuite de l'actualisation des bases de données des cas confirmés, des décès, des guérisons, des alertes et des contacts, en collaboration avec les équipes de surveillance et les autres piliers techniques ;
- Renforcement de l'utilisation du DHIS2 Tracker pour l'enregistrement, le suivi et la consolidation des données individuelles des cas et des contacts ;
- Identification et correction progressive des doublons, des données manquantes et des incohérences dans les bases de données, particulièrement celles relatives aux cas, aux décès et à leur répartition par zone de santé ;
- Production et actualisation des tableaux de bord de pilotage de l'Incident Manager, des synthèses provinciales et nationales ainsi que des indicateurs de performance des différents piliers ;
- Renforcement du partage régulier des données entre les DPS, les coordinations provinciales, la Direction de la Surveillance Épidémiologique et la Coordination nationale pour faciliter la prise de décisions fondées sur les données ;
- Poursuite de l'harmonisation des outils de collecte et de rapportage, ainsi que de l'accompagnement technique des gestionnaires de données dans les provinces affectées.

2.13.2. Défis majeurs

Persistance des insuffisances dans la complétude, la qualité, la promptitude et la concordance des données transmises par certaines provinces, nécessitant le renforcement du contrôle qualité, de l'interopérabilité des bases de données et de l'utilisation du DHIS2 Tracker pour garantir la fiabilité des indicateurs et orienter efficacement les décisions opérationnelles de la riposte.

MESSAGES CLES

- Des progrès encourageants sont enregistrés dans la réduction de la mortalité, avec 32 décès confirmés contre 37 la veille et 33 le 08 octobre. Les décès communautaires ont diminué de 22 à 18 par rapport à la veille (−18,2 %), tandis que les décès intra-CTE sont passés de 19 le 08 octobre à 14 (−26,3 %).
- Une amélioration est observée au Nord-Kivu, où les nouveaux cas ont diminué à 22, contre 28 la veille et 30 le 08 octobre. Toutefois, 71 nouveaux cas ont été notifiés au niveau national, contre 65 la veille et 58 le 08 octobre. L'Ituri demeure l'épicentre avec 41 cas, dont 21 à Mandima.
- La prise en charge continue de produire des résultats, avec 21 nouvelles guérisons, portant le cumul à 2 507 patients guéris, contre 2 486 la veille et 2 320 le 08 octobre. La létalité nationale a légèrement diminué à 48,2 %, contre 48,3 % aux deux dates de comparaison.
- La surveillance épidémiologique montre une progression, avec un taux de suivi des contacts de 79,2 %, contre 78,0 % la veille. Toutefois, ce niveau reste inférieur à la cible de 95 %, nécessitant une intensification du suivi des contacts et des investigations dans les foyers actifs.
- Les interventions de riposte se poursuivent dans les provinces affectées, notamment la prise en charge, la PCI/EDS, la vaccination des personnes de première ligne et la mobilisation communautaire. Les efforts doivent être renforcés dans les zones de santé de Mandima, Beni et Bafwasende, où persistent des risques importants de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.

- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.